

# 360° Klinik Yönetici ve Karar Destek Raporu

Alaattin Sönmez (64E) · 09 Eylül 2026 · Postoperatif 202. Gün

## 1. Hasta Künyesi

| Alan             | Değer                             |
|------------------|-----------------------------------|
| Ad Soyad         | Alaattin SÖNMEZ                   |
| TC               | 00000000000                       |
| Yaş / Cinsiyet   | 64 / Erkek                        |
| Doğum            | 01.01.1962 / HATAY                |
| Boy / Kilo / VKİ | 174 cm / 78.8 kg / 26.0           |
| Kan Grubu        | 0 Rh (+)                          |
| Güvence          | SSK / Hatay                       |
| Ameliyat         | 20 Şubat 2026 (Bentall Prosedürü) |

## 2. Yönetici Klinik Özet

Alaattin Sönmez (64E), 19 Şubat 2026'da ani başlayan yırtıcı karakterde göğüs-sırt ağrısı ile Defne Devlet Hastanesi'ne başvurmuş; sevk zinciri sonrası **5.3 cm asendan aort anevrizması ve Tip A Aort Diseksiyonu** kesin tanısı ile Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'ne yatırılmıştır (Isselbacher et al., 2022, s. e340). 20 Şubat 2026'da derin hipotermik sirkülatuar arrest altında **32 mm Maquet Intergard Dacron greft ve 25 mm CORCYM Carbomedics mekanik kapak** implante edilerek Bentall prosedürü tamamlanmıştır (Bentall & De Bono, 1968, s. 211). Postoperatif dönemde sternal dehissens (23-28 Temmuz 2026 revizyonu), geçici INR dalgalanmaları (zirve 8.46) ve mikroskopik demir eksikliği anemisi gelişmiştir.

Son 7 gün ortalama kan basıncı **111/76 mmHg** ile 2024 ESC hedefinin ( $\leq 120/80$ ) altındadır (McEvoy et al., 2024). INR 2.72 ile mekanik aort kapak için terapötik pencerededir (Vahanian et al., 2022, s. 584). Ancak 4 kritik başlık sürmektedir: (1) mikrositer anemi (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19 µg/L), (2) TTR %54.6 ile suboptimal antikoagülasyon, (3) CRP 11.3 mg/L ile subakut enflamasyon, (4) rezidüel Tip B

diseksiyon flebi nedeniyle 6-aylık görüntüleme ihtiyacı (Fleischmann et al., 2022, s. e000075).

### 3. Biyobelirteç Değişim Tablosu

| Parametre | Referans  | İlk   | Zirve/Dip | Son   | %Δ     | Trend      |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------------|
| INR       | 2.0-3.0   | 1.10  | 8.46      | 2.72  | +147%  | Hedefe     |
| HGB       | 13.5-17.5 | 14.0  | 7.7       | 9.7   | -30.7% | Anemi      |
| MCV       | 80-100    | 88.0  | 76.4      | 76.4  | -13.2% | Mikrositer |
| Ferritin  | 30-400    | 19    | 19        | 19    | —      | Depo boş   |
| CRP       | 0-5       | 2.6   | 154       | 11.3  | -92.7% | Gerilemede |
| WBC       | 4.5-11    | 10.62 | 27.1      | 7.97  | -25%   | Normal     |
| Kreatinin | 0.6-1.3   | 1.11  | 0.76      | 1.02  | -8.1%  | Stabil     |
| eGFR      | >60       | 72.58 | 72.58     | 75.58 | +4.1%  | Normal     |
| LDL       | <70       | 119.6 | 141       | 141   | +17.9% | Yüksek     |
| TSH       | 0.27-4.2  | 0.86  | 0.28      | 0.28  | -67.4% | Sınırdadır |

### 4. Aylık Kan Basıncı Özeti

| Ay           | n  | Ortalama   | Min    | Maks    |
|--------------|----|------------|--------|---------|
| Mart 2026    | 69 | 109.2/76.8 | 83/60  | 154/98  |
| Nisan 2026   | 96 | 109.4/77.8 | 85/60  | 168/103 |
| Mayıs 2026   | 63 | 118.6/80.2 | 100/68 | 140/95  |
| Haziran 2026 | 68 | 127.2/84.6 | 109/72 | 149/99  |
| Temmuz 2026  | 84 | 124.9/83.2 | 102/60 | 149/101 |
| Ağustos 2026 | 89 | 118.7/79.9 | 99/65  | 139/95  |
| Eylül 2026   | 18 | 111.2/75.7 | 103/68 | 122/82  |

### 5. TTR Analizi

38 INR ölçümü, Rosendaal lineer interpolasyonu ile **TTR %54.6** (hedef >%70; Vahanian et al., 2022, s. 584; Rosendaal et al., 1993, s. 236). Kritik sapmalar: 16 Mart 2026 INR 8.46 (supraterapötik), 27 Temmuz 2026 INR 1.17 (köprüleme öncesi).

## 6. İnteraktif İlaç Etkileşim Matrisi

| Çift                             | Ri<br>sk       | Mekanizma                                                     | Yönetim                               |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Warfarin ×<br>Klamoks            | Kr<br>iti<br>k | Barsak florası K vit. sentezi<br>baskısı + CYP2C9 inhibisyonu | Kür sonrası 48-72<br>saat kontrol INR |
| Karvedilol ×<br>Perindopril      | Yü<br>ks<br>ek | Sinerjik vazodilatasyon                                       | İlk dozda oturur<br>pozisyon          |
| Warfarin ×<br>Aspirin            | Yü<br>ks<br>ek | Hemostatik plug + kaskad<br>inhibisyonu                       | Yıllık gaita gizli kan                |
| Demir × Panto                    | Yü<br>ks<br>ek | Mide pH artışı demir emilimini<br>azaltır                     | 1 saat önce uygula                    |
| Ciprofloksasin<br>× Warfarin     | Yü<br>ks<br>ek | CYP1A2 inhibisyonu                                            | INR takibi                            |
| Perindopril ×<br>Warfarin        | Or<br>ta       | PAI-1 azalması                                                | Rutin takip                           |
| Panto ×<br>Aspirin ×<br>Warfarin | Yü<br>ks<br>ek | Kombine kanama riski                                          | Endoskopik takip                      |

## 7. Kronolojik Klinik Zaman Çizelgesi

- **19 Şub 2026:** Defne DH → MKÜ → Kırıkhan DH → İskenderun Gelişim (acil sevk zinciri)
- **20 Şub 2026:** Bentall prosedürü (32 mm Dacron + 25 mm Carbomedics)
- **02 Mar 2026:** Şifa ile taburcu, yaşam boyu warfarin
- **16 Mar 2026:** INR 8.46 zirve, aspirin kesildi
- **30-31 Mar 2026:** Genel Cerrahi yatışı (kabızlık, lavman)
- **16-18 Nis 2026:** Ardışık 3 hipertansif kriz (168/103 mmHg zirve)
- **23-28 Tem 2026:** Sternal dehissens revizyonu, kan transfüzyonu
- **04 Ağu 2026:** Coversyl eklendi
- **04 Eyl 2026:** Klamoks ampirik başlandı
- **09 Eyl 2026:** Stabil takip

## 8. Branş Bazlı Eylem Planı

**Hematoloji:** IV Ferrik Karboksimaltoz 500-1000 mg (Ferritin <100; McDonagh et al., 2021, s. 3649). **Kardiyoloji:** Klamoks sonrası kontrol INR; LDL 141 için statin (ESC 2024). **KVC/Radyoloji:** 6-aylık kontrol aort BT Anjiyografi (Fleischmann et al., 2022). **Enfeksiyon:** Diş işlemleri öncesi amoksisilin 2 g profilaksi (Habib et al., 2015). **Genel Cerrahi:** Sternal yara takibi; CRP <5 hedefi. **Kardiyoloji:** BP hedefi sürdürme (McEvoy et al., 2024). **Nefroloji:** Kreatinin ve potasyum stabil takip (KDIGO 2023).

## 9. Kaynakça (APA 7th Edition)

1. **Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., et al. (2022).** 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482.
2. **Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., et al. (2022).** 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632.
3. **Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023).** 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.
4. **Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024).** EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.
5. **McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., et al. (2024).** 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3897–3972.
6. **Fleischmann, D., Afifi, R. O., Casanegra, A. I., et al. (2022).** Imaging and Surveillance of Chronic Aortic Dissection: A Scientific Statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), e000075.
7. **Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2021).** British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051.
8. **McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., et al. (2021).** 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726.

9. **Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J., & Briët, E. (1993).** A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236–239.
10. **KDIGO. (2024).** Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 105(4S), S117–S314.

## 10. Sorumluluk Reddi

Bu rapor, hastanın nesnel klinik verilerinin uluslararası kılavuzlarla sentezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir **klinik karar destek aracıdır**. Tıbbi tanı, reçete veya tedavi kararı niteliği taşımaz. Nihai kararlar tedavi eden hekim heyetine aittir. Rapor kodu: CLN-360-KDD-20260909.